

ESPASMO DEL SOLLOZO

Bibliografía Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Bibliografía: Dr. Ricardo Bernztein. Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Servicio de Clínica Pediátrica - Mediano Riesgo.

Frecuencia:

Formas severas: 4,6% de la población infantil

Formas leves 27%

Tipos: pálido, cianótico y el mixto

ES pálido (19-22% de los ES)

Es un equivalente del síncope vasovagal en los lactantes y niños de primera infancia, debido a un trastorno del sistema nervioso autónomo. Consiste en la pérdida de conocimiento que sigue a factores precipitantes como estrés emocional, temor, dolor, ayuno, posición de pie. En los lactantes suele existir el antecedente de un trauma o injuria (frecuentemente cefálico).

Los pródromos del síncope consisten en mareos, visión borrosa, palidez intensa, sudoración, náuseas, produciéndose una súbita e inesperada pérdida de conciencia. Existe un fenómeno de hipotensión sistémica (respuesta vasodepresora), y bradicardia o asistolia (respuesta cardioinhibidora).

Representa un.

ES cianótico (64-62% de los ES)

Rápido desarrollo de la cianosis que resulta de una compleja interrelación entre la hiperventilación seguida de una apnea espiratoria, caracterizado por llanto enérgico desencadenado por frustraciones.

Se distinguen 4 grados:

- Grado 1. Llanto con inspiración prolongada y apnea breve.
- Grado 2. Llanto, inspiración prolongada, apnea y acrocianosis.
- Grado 3. Llanto, inspiración prolongada, apnea, cianosis e hipo- o hipertonía.
- Grado 4. Llanto, inspiración prolongada, apnea, cianosis, hipertonía y sacudidas clónicas generalizadas.

Mixtos o inclasificables (19-24% de los ES)

La edad de ocurrencia más frecuente es entre los 6 meses y los 4 años. El 90% de los casos ha tenido su primer ES antes de los 2 años. Prácticamente todos los casos han cesado a los 7 u 8 años.

La anemia y la fiebre son reconocidos factores que contribuyen al ES.

Diagnóstico diferencial

Convulsiones epilépticas, en éstas, los cambios en el tono muscular y postura son previos a los cambios de coloración, y no se desencadenan por llanto o injuria.

El síncope ortostático, la apnea, los tumores ocultos del SNC, las malformaciones ocultas del SNC como el Arnold Chiari, la disautonomía familiar, el síndrome de Rett, el reflujo gastroesofágico, las arritmias cardíacas constituyen otros diagnósticos diferenciales.

El síndrome del QT prolongado si bien infrecuente, es una causa potencialmente maligna de convulsiones anóxicas.

El síncope o las convulsiones son inducidos por taquicardia ventricular o asistolia secundarios al ejercicio, excitación, injuria o miedo. **Se recomienda para descartar este cuadro realizar un ECG en todo paciente con ES.**

Sin embargo, la historia natural y secuencia típica caracterizan el ES y hacen rara vez necesarios exámenes complementarios como el EEG o imágenes cerebrales.

Desde las clasificaciones neurológicas el ES es considerado un **trastorno paroxístico no epiléptico**.

Fisiopatología

Lombroso y Lerman proponen una combinación de factores en el origen del **ES C** como:

- 1- llanto enérgico que origina hipocapnia e isquemia cerebral;
- 2- apnea e hipoxemia;
- 3- aumento de la presión intratorácica por espasmo espiratorio;
- 4- disminución del volumen minuto cardíaco;
- 5- hipoflujo cerebral secundario.

El ES pálido es un equivalente del síncope vasovagal en los lactantes y niños de primera infancia. A diferencia del ESC, no es la hipoxemia el mecanismo que origina la pérdida de conocimiento.

Enfoque psicossomático

Si bien no se sigue considerando al ES como voluntario, existe la opinión de que los niños con espasmos son más desobedientes, caprichosos, agresivos.

Trastorno del control cardiorrespiratorio

Kahn, en un estudio prospectivo con casos control. La fragmentación del sueño, la sudoración, el sueño no REM e indeterminado, el ronquido durante el sueño, el número y la duración de apneas obstructivas fue mayor en el grupo de niños con ES.

La anemia

Los niños con ES severo tenían niveles de hemoglobina significativamente más bajos que los niños de un grupo control. Se considera que estos pacientes son más susceptibles a los eventos que llevan al síncope.

La irritabilidad de los niños con deficiencia de hierro está ampliamente demostrada, también se observa que su corrección disminuye la frecuencia de los espasmos.

El hierro es importante en el metabolismo catecolaminérgico y en la función de varias enzimas y neurotransmisores del sistema nervioso central.

La herencia

El ES fue observado en el 20 a 30% de las familias con niños con ES severos.

Tratamiento

La explicación del fenómeno y el tranquilizar de los padres constituyen el principal estadio del tratamiento.

Pautas para padres:

1. Mantenga la calma.
2. Retire los objetos que el niño tenga en la boca.
3. Colóquelo de costado y retire los objetos con los que se pueda golpear.
4. Mantenga un ambiente bien ventilado, afloje la ropa.
5. No intente detener el espasmo.
6. Háblele suavemente.
7. Al término del espasmo déjelo dormir una pequeña siesta.
8. En caso de que sea provocado por dolor bríndele consuelo y alivio.

Evitar:

1. Maniobras de reanimación.
2. Golpear o bañar al niño con agua fría. Existe el riesgo de broncoaspiración y complicaciones pulmonares.
3. No introduzca objetos en su boca ya que puede lesionarla o provocar sofocación.
4. Es muy importante no confundirlo con otras enfermedades convulsivas, evitar en lo posible la administración de medicamentos antiepilépticos.

Para los ES severos o en edades atípicas se deberían establecer controles más rigurosos.

A pesar de que el ES no es voluntaria sino refleja, la ansiedad exagerada de los padres puede enseñar al niño a manejar con el llanto a los padres.

También es aconsejable intentar evitar en la medida de lo posible los desencadenantes.

Se justifica realizar un dosaje de hemoglobina a todos los niños con ES, **aunque también se demostró que la ferroterapia es útil aún sin deficiencia de hierro.**

A niños que escapan a la historia habitual esperable del ES, ya sea por ser menores de 6 meses, presentar hipoxemias muy severas o convulsiones frecuentes habría que monitorearlos y se puede colocar presión positiva continua de la vía aérea.

Algunos autores recomiendan el uso de piracetam en pacientes con espasmo del sollozo recurrente.

No se justifica tratamiento antiepiléptico.

El seguimiento a largo plazo sugiere que los espasmos del sollozo se alivian espontáneamente.

Los pacientes presentan mayor frecuencia de problemas de atención y, en el caso de espasmos pálidos, pueden presentar con mayor frecuencia síncope.

Indicación de EEG

Paciente menor de 6 meses o mayor de 4 años

Ausencia de mecanismo desencadenante evidente

Sospecha de convulsión.

Indicación de Electrocardiograma

En caso de espasmo del sollozo pálido. Para descartar arritmias o síndrome de QT largo.